

Rheumatic Fever – Simplified Bilingual Notes

(حمى الروماتيزم – شرح مبسّط ثنائي اللغة)

Learning Objectives (أهداف التعلم)

- Define rheumatic fever and its etiology.
- تعريف حمى الروماتيزم وسبب حدوثها.
- Describe the pathophysiology and Jones criteria for diagnosis.
- شرح آلية المرض ومعايير جونز للتشخيص.
- Identify clinical manifestations and complications.
- تحديد الأعراض والمضاعفات.
- Discuss management, prevention, and nursing care.
- مناقشة العلاج والوقاية ودور التمريض.

Introduction (المقدمة)

Rheumatic fever is an inflammatory disease that occurs after infection with Group A Streptococcus.

A. حمى الروماتيزم هي مرض التهابي يحدث بعد عدوى بكتيريا المكورات العنقودية من المجموعة

It mainly affects the heart, joints, skin, and central nervous system.

تؤثر بشكل أساسي على القلب والمفاصل والجلد والجهاز العصبي المركزي.

It commonly affects children between 5–15 years.

تظهر غالبًا عند الأطفال من عمر 5–15 سنة.

If untreated, it may lead to chronic rheumatic heart disease.

وإذا لم تُعالج قد تؤدي إلى مرض قلبي روماتيزمي مزمن.

Etiology & Pathophysiology (السبب وآلية المرض)

Rheumatic fever is a delayed autoimmune reaction after throat infection with Group A Streptococcus.

A. حمى الروماتيزم هي استجابة مناعية متأخرة بعد عدوى حلقية ببكتيريا المجموعة

The body produces antibodies that mistakenly attack heart, joints, brain, and skin.

الجسم ينتج أجسامًا مضادة تهاجم القلب والمفاصل والدماغ والجلد بالخطأ.

This causes inflammation called pancarditis (inflammation of all heart layers).

يسبب التهابًا عامًا في القلب يسمى التهاب القلب الشامل.

Clinical Features & Diagnosis (الأعراض والتشخيص)

Diagnosis is based on the revised Jones criteria plus proof of recent streptococcal infection.

يتم التشخيص باستخدام معايير جونز المعدلة مع وجود دليل على عدوى سابقة بالبكتيريا

Major Criteria (المعايير الكبرى)

- Carditis
 - التهاب القلب
 - Polyarthritits
 - التهاب مفاصل متعدد
 - Chorea (Sydenham's chorea)
 - رقص سيدنهام (حركات لا إرادية)
 - Erythema marginatum
 - طفح جلدي مميز
 - Subcutaneous nodules
 - عُقيدات تحت الجلد
-

Minor Criteria (المعايير الصغرى)

- Fever
- حمى

- Arthralgia
 - ألم بالمفاصل
 - Elevated ESR or CRP
 - ارتفاع معدل الالتهاب (ESR أو CRP)
 - Prolonged PR interval on ECG
 - في تخطيط القلب PR إطالة فترة
-

Management (العلاج)

1. Antibiotic therapy: Benzathine penicillin G (single IM injection).
(حقنة عضل واحدة) G مضاد حيوي: بنزاثين بنسلين ١.
 2. Anti-inflammatory drugs: aspirin or corticosteroids.
أدوية مضادة للالتهاب: الأسبرين أو الكورتيزون ٢.
 3. Supportive care: rest, nutrition, fluids.
رعاية داعمة: الراحة والتغذية الجيدة والسوائل ٣.
 4. Long-term prophylaxis: monthly penicillin injections for 5–10 years or until adulthood.
الوقاية الطويلة: حقنة بنسلين كل شهر لمدة 5–10 سنوات أو حتى سن البلوغ ٤.
-

Nursing Care (دور التمريض)

- Monitor vital signs and cardiac function.
مراقبة العلامات الحيوية ووظائف القلب
- Give prescribed medications and antibiotics.
إعطاء الأدوية والمضادات الحيوية الموصوفة
- Educate family about adherence to prophylaxis.
توعية الأسرة بأهمية الالتزام بالحقن الوقائية
- Encourage rest during acute episodes.

- تشجيع المريض على الراحة أثناء المرحلة الحادة.
 - Promote oral and throat hygiene to prevent infections.
 - تعزيز نظافة الفم والحجرة لمنع العدوى.
-

Prevention (الوقاية)

- Primary prevention: treat throat infections early.
 - الوقاية الأولية: علاج التهاب الحلق مبكرًا.
 - Secondary prevention: continue long-term monthly penicillin.
 - الوقاية الثانوية: الالتزام بحقن البنسلين الشهرية لفترات طويلة.
-

Summary (الخلاصة)

Rheumatic fever is a serious autoimmune disease that can cause long-term heart damage.

حمى الروماتيزم مرض مناعي خطير قد يسبب تلف قلب مزمن.

Early diagnosis and proper treatment reduce complications.

التشخيص المبكر والعلاج الصحيح يقللان من المضاعفات.

Prevention and long-term prophylaxis are essential.

الوقاية والمتابعة بالحقن الشهرية ضرورية جدًا.